המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א' 2022

גריאטריה - בסיס

מס' השאלות בחלק זה :150

1. מה היעילות של טיפול תרופתי באי ספיקת לב HFpEF?

א. כל חוסמי הבטא הוכחו כמפחיתים תמותה (class effect)
ב. טיפול ב- DIGOXIN הוכח כמפחית אשפוזים, אך לא מפחית תמותה
ג. טיפול ב- FUROSEMIDE הוכח כמפחית אשפוזים ומאריך חיים
ד. מעכבי SGLT2 הוכחו כמפחיתים תמותה בחולי סוכרת בלבד

2. בן 88, עצמאי בתפקודו ושמור קוגניטיבית, מבצע פעילות גופנית, גר בבית עם אשתו, ללא מחלות רקע משמעותיות וללא טיפול תרופתי קבוע. . פנה למוקד רפואי בקהילה עקב חום ושיעול.
סימנים חיוניים: חום 38, דופק 88 לדקה, לחץ דם 130\80, נשימות 16בדקה.
בבדיקה ערני, נינוח, ללא דליריום, בהאזנה לריאות קריפיטציות משמאל.
בדיקות מעבדה- המוגלובין תקין, ללא לויקוציטוזיס, תפקודי כליה תקינים, CRP-30.
בצילום חזה – תסנין משמאל
החולה מבקש לקבל טיפול בביתו ולא באשפוז.
איזה טיפול אנטיביוטי אפשר לרשום לחולה זה בבית?

א. Clavulanic Acid+Amoxicillin (אוגמנטין)
ב. Cefuroxime (זינט)
ג. Cefuroxime (זינט) + Clindamycin (דלצין)
ד. Cefuroxime (זינט) + Azithromycin (אזניל)

3. בת 75 , ברקע דמנציה, דיכאון, סוכרת, יתר לחץ דם ואוסטאוארטריטיס. התקבלה למחלקה לרפואה דחופה עקב החמרה בתפקודי כליה.
בבדיקות המעבדה נמצאה אי ספיקה כלייתית עם קריאטינין 2.3 ו- BUN -70. בבדיקה לפני חצי שנה- קריאטינין 1.2 ו- BUN תקין.
מתוך כל התרופות שלקחה בביתה – כולן יכולות לגרום לאי ספיקה כלייתית חדה <u>פרט ל-</u>

א. Etoricoxib (ארקוקסיה)
ב. Empagliflozin (ג'רדיינס)
ג. Candesartan (אטקנד)
ד. Ecitralopam (ציפרלקס)

4. בן 81 מתקבל להערכה לפני ניתוח החלפה שלמה של מפרק ירך עקב אוסטאוארתריטיס קשה. מתלונן על ירידה תפקודית המגבילה את יכולתו ללכת ללא עזרה.
ברקע – יתר לחץ דם, סוכרת, היפרליפידמיה, אי ספיקת כליות כרונית, אוסטאוארתריטיס.
בתרופותיו – Insulin, Atorvastatin, Paracetamol.
בבדיקה גופנית ישנה הגבלת בטווחי תנועה בירך.
אק"ג – <u>תמונה מספר 1</u>
מה נדרש כחלק מהברור וההכנה הקרדיאלית לניתוח?

א. אין צורך בבירור קרדיאלי נוסף לפני ניתוח זה
ב. יש צורך מבחן מאמץ על הליכון חשמלי או אופני כושר
ג. יש צורך צנתור קורונרי לאחר הכנה כילייתית
ד. יש צורך מבחן מאמץ פרמקולוגי עם הדמיה כגון אקו דובוטמין

5. בן 82, ברקע יל״ד מאוזן תרופתית. מאושפז בטיפול נמרץ בשל ספסיס על רקע דלקת ריאות. הוא מונשם, לאחר שלושה ניסיונות גמילה שלא צלחו. מעוניינים להתקדם לביצוע טרכאוסטומיה. המטופל אינו מסוגל להביע דעתו, אך יש ברשותו מספר מסמכים משפטיים שכולם תקינים ובתוקף.
מה סוג המסמך שיש להפעיל במצבו הנוכחי?

א. יפוי כח מתמשך
ב. יפוי כח לפי חוק החולה הנוטה למות
ג. הנחיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות
ד. תעודת רופא לאפוטרופסות

6. בן 85 מאושפז בטיפול נמרץ לאחר ניתוח החלפת מסתם אאורטלי. במהלך האשפוז סבל מספסיס. בבדיקות המעבדה נצפתה ירידה בטסיות מ- 247,000 בקבלתו לטיפול נמרץ ל- 87,000.
באבחנה מבדלת הועלתה אפשרות של HIT- Heparin Induced Thrombocytopenia.
איזה ממצא יתאים לאבחנה זו?

א. PTT מאורך
ב. ירידה בטסיות 48 שעות לאחר התחלת טיפול ב- Heparin
ג. ממצא של DVT חדש
ד. בדיקת דם חיובית ל- anti IIb/IIIa antibodies

7 . מי מהחולים הבאים יפיק תועלת מבדיקת הסקר לממאירות?

א. בדיקת סקר לערמונית לגבר בן 90, עצמאי ושמור קוגניטיבית
ב. בדיקת סקר ללבלב, לגבר בן 65, בריא, ששני הוריו נפטרו מהמחלה
ג. בדיקת סקר לשד, לאישה בת 72, ברקע סוכרת, אינה נשאית גן BRCA
ד. בדיקת סקר למעי גס, לאישה בת 77, עם אי ספיקת לב סופנית על רקע מחלת לב איסכמית

8. בן 80, המוכר כסובל מדמנציה, אושפז במחלקה פנימית. הוא עבר אבחון גריאטרי בקהילה לפני חודש. נמצא MMSE 18/30, והוזמן גריאטר כדי להגדירו כ"תשוש נפש" לצורך סידור מוסדי.
באיזה מצב ניתן להגדיר את המטופל כ"תשוש נפש"?

א. המטופל מרותק למיטה, לא שולט על סוגרים, צועק ביום ובלילה, נזקק לטיפול בתכשירים אנטי-פסיכוטיים
ב. המטופל מתהלך, מסרב להתקלח, יוצא מהמחלקה ולא יודע לחזור
ג. המטופל מתהלך, שולט על סוגרים, משתף פעולה בטיפול, לא מתמצא בזמן ובמקום, מסכים לעבור למסגרת מוסדית
ד. למטופל החמרה חריפה במצבו הקוגניטיבי עם הזיות ראיה

9. בן 80 פלוני אלמוני הובא למחלקה לרפואה דחופה לאחר נפילה ברחוב. לא ידוע שום רקע רפואי אך בתיקו נמצאו כדורי PREDNISONE 5 מ"ג ועט אינסולין LANTUS.
סימנים חיוניים- דופק 130 לדקה לחץ דם 90/60 סטורציה 92 ללא חום
בבדיקה גופנית- השמנה מרכזית, חיוורון, עור עם שטפי דם מרובים, רגל ימין ב-LATERAL ROTATION נפוחה עם רגישות בסובך.
רמת גלוקוז בדם בסטיק 160 מג% .
אובחן שבר פרה-טרוכנטרי.
מה הצעד הטיפולי הבא הנדרש:

א. לתת 2 מנות דם מסוג O ללא הצלבה ו 6 מנות טסיות
ב. מתן אינסולין קצר טווח
ג. מתן SC CLEXAN במינון 80 מ"ג
ד. מתן HYDROCORTISONE תוך ורידי

10. מה נכון לגבי הטיפול ב- Idiopathic Pulmonary Fibrosis ?

א. רוב החולים מגיבים זמנית לטיפול בסטרואידים במינון גבוה
ב. הטיפול בשילוב של סטרואידים, azathioprine ו- N-acetylcysteine הוכח כמפחית אשפוזים אך לא כמאריך תוחלת חיים
ג. הטיפול ב- pirfenidone משפר איכות חיים אך ללא השפעה משמעותית על מהלך המחלה
ד. יש לשלב טיפול פליאטיבי משלב מוקדם של המחלה

11. מטופל בן 80, מועמד לניתוח החלפה אלקטיבית של פרק ברך עקב אוסטאוארטריטיס מתקדם. מקבל טיפול קבוע ב- CLOPIDIGREL עקב אוטם שריר הלב והכנסת STENT לפני שנתיים.
מה ההתייחסות לטיפול ב- CLPIDOGREL כהכנה לניתוח?

א. יש להפסיק טיפול ב CLOPIDOGREL 5-7 ימים לפני הניתוח למניעת דמם
ב. יש להפסיק טיפול ב- CLOPIDOGREL שבוע לפני הניתוח ולתת טיפול חלופי ב- ENOXAPARIN (קלקסן)
ג. אין צורך להפסיק את הטיפול. מדובר בניתוח שניתן לבצע תחת נוגדי טסיות
ד. יש להפסיק CLOPIDOGREL רק אם הניתוח מבוצע בהרדמה ספינלית

12. בת 86, תשושה בתפקודה וסובלת מירידה קוגניטיבית קלה. מתגוררת בביתה עם עזרה של "חוק סיעוד". הגיעה למרפאה נפרולוגית למעקב עקב אי ספיקה כלייתית מתקדמת עם CCT-15 מ"ל/דקה.
מה הקשר האפשרי בין שבריריות (FRAILTY) לאי ספיקה כלייתית?

א. היות והשבריריות היא משנית לאורמיה התחלה מוקדמת של דיאליזה תשפר את מצבה
ב. חולים שבריריים נוטים להגיע מאוחר לדיאליזה מחשש להחמרה במצבם
ג. נוכחות שבריריות בחולה דיאליזה מלווה בפרוגנוזה גרועה יותר
ד. שבריריות מופיעה בחולי אי ספיקה כלייתית רק ב- CCT 30 מ"ל/דקה ומטה

13. בן 86, הגיע למרפאה עקב תלונות על גרד ואודם ברגליים, שידוע מזה זמן רב, אך לאחרונה החמיר. בבדיקתו רושם לעור מחוספס ומגרד, יבש, סדוק.

תמונה מספר 2

מה הטיפול הראשוני לממצאים בעור?

א. אנטיביוטיקה מקומית (Benzoil peroxide, Erythromycin ו- metronidazole)
ב. חומרי לחות, קורטיקוסטרואידים מקומיים קלים לזמן מוגבל
ג. נוגדי פטריות מקומיים (Miconazole)
ד. Crotamiton (סקביצין)

14. בת 76, הסובלת מיתר לחץ דם. מטופלת ב- ENALAPRIL (אנלדקס), BISOPROLOL (קרדילוק) , VALSARTAN (דיובן) ו- DOXAZOCIN (קדקס). מתלוננת על נדודי שינה בחודשים האחרונים.
איזו מהתרופות הקבועות שלה יכולה לפגוע באיכות השינה בסבירות הגבוהה ביותר?

א. ENALAPRIL
ב. BISOPROLOL (קרדילוק)
ג. VALSARTAN (דיובן)
ד. DOXAZOCIN (קדקס)

15. מהו "דגל אדום" לכאבי גב משניים למחלה סיסטמית?

א. רקע של סוכרת מטופלת באינסולין
ב. רקע של COPD קשה תלוי בסטרואידים
ג. משך סימנים מעל שבועיים
ד. כאב מוקל בכפיפה קדימה

16. בת 83, גרה לבדה. ללא עזרה מ"חוק סיעוד". עד לאשפוזה התהלכה עם קוודריפוד והיתה עצמאית ב- ADL. ברקע- SLEEP APNEA המטופלת ב- CPAP מזה שנתיים. מאושפזת לאחר נפילה ושבר בכתף ימין. אורתופד המליץ על קיבוע של הכתף ל- 6 שבועות. החולה מוגבלת בהזזת יד ימין, נזקקת לעזרה ב- ADL ומתקשה להחזיק את הקוודריפוד. אין החמרה במצבה הנשימתי.
מה **נכון** לגבי תכנית השיקום?

א. היות ולא מדובר בשבר ברגל אין אינדיקציה לשיקום באשפוז
ב. החולה זקוקה למסגרת סיעודית עד להחלמת השבר ואז תעבור לשיקום
ג. רקע של בעיה נשימתית המצריכה CPAP הוא קונטראינדיקציה לשיקום
ד. אם אין מערכת תמיכה בבית מתאימה לשיקום באשפוז

17. איזה תסמין של מחלת פרקינסון שייך ל- Nonmotor Features?

א. Constipation
ב. Dysphagia
ג. Drooling
ד. Masked facies (hypomimia)

18. מהו גורם הסיכון החשוב ביותר בדמנציה על רקע אלצהיימר?

א. גיל
ב. דיכאון
ג. חבלת ראש בעבר
ד. Apolipoprotein E genotype

19. בן 78, מהנדס במקצוע, בגמלאות, אלמן כשלושה חודשים, הילדים תומכים בו, מתגורר לבד בבית פרטי. הגיע לייעוץ עקב ירידה קוגניטיבית.
הוא דיווח שבחודשיים האחרונים הוא מרגיש ירידה בזיכרון טווח קצר – שוכח איפה שם חפצים, שואל שוב ושוב את אותה שאלה. בנוסף מתקשה להתרכז בקריאה או בטלוויזיה.
ברקע: סוכרת, יתר לחץ דם ויתר שומנים בדם, מ/א אירוע מוחי איסכמי קל ללא חסרים נוירולוגיים. מאוזן מבחינת מחלות הרקע תחת טיפול תרופתי.
מבחן MMSE - **תמונה מספר 3**
עברה שנה והמטופל הגיע למרפאה למעקב. בדיקת MMSE היתה 28/30.

איזה טיפול סביר שקיבל?

א. מעכבי אצטיל כולין
ב. נוגדי דיכאון
ג. קנאביס רפואי
ד. תרגול קוגניטיבי

20. מי מהבאים נחשב כ- prescribing cascade בגריאטריה?

א. טיפול במצב פסיכוטי על ידי HAPOERIDOL -> הופעת סימנים אקסטרא-פירמידלים -> החלפת הטיפול ב- QUETHIAPINE (סרוקוול)
ב. טיפול בכאב גב על ידי טיפול ב- ETODOLAC (אטופן) -> הופעת גאוט -> טיפול ב- ALLOPURINOL
ג. טיפול ב- DONEPEZIL לדמנציה -> הופעת אי שליטה על שתן -> התחלת טיפול ב- FESOTERODINE (טוביאז)
ד. טיפול בבחילות על ידי METOCHLOPRAMIDE (פראמין) -> הופעת פרקינסוניזם -> הפסקת התרופה

21. איזה טיפול תרופתי **אינו מומלץ** בקשישים על פי AGS BEERS CRITERIA 2019 ?

א. Amiodarone כקו שני לטיפול בפרפור עליות
ב. Proton-pump inhibitors בשימוש ליותר מ- 8 שבועות, פרט למטופלים בסיכון גבוה
ג. Lactulose (לבולק) לטיפול בעצירות בנשים בלבד
ד. תרופות ממשפחת ה- Sulfonylureas רק בחולים עם CCT>30

22. מה כוללת שיטת DICE להתמודדות עם הפרעות התנהגות של דמנציה?

א. Describe, Investigate, Create, and Evaluate
ב. Discuss, Irritate, Concentrate and Erase
ג. Don't, Interfere, Calm and Elaborate
ד. Do, Ignore, Call and Establish

23. בן 78, עם רקע של מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, סוכרת ויתר לחץ דם. בשנה האחרונה ירידה לא רצונית במשקל של 7 ק"ג.
מה מהממצאים הבאים יעזור לאבחן שבריריות אצל המטופל, על פי המודל של FRIED AND WALSTON?

א. המטופל יושב רוב היום על הספה, וממעט לקום
ב. למטופל ציון מינימנטל (MMSE) של 23/30
ג. המטופל אושפז פעמיים בשנה האחרונה
ד. באקו לב מקטע הפליטה של חדר שמאל 35%

24. בת 76, עצמאית וללא ירידה קוגניטיבית, ברקע סוכרת, יתר לחץ דם ואוסטאוארטריטיס. תרופות- METFORMIN, AMLODIPINE ו- IBUPROFEN לפי הצורך. הגיעה למחלקה לרפואה דחופה לאחר אירוע של נפילה בביתה בזמן מקלחת. היא מתארת שבזמן המקלחת הרגישה סחרחורת ו"ראתה שחור בעיניים". היא איבדה הכרה למספר דקות ונפלה על כיסא שהיה לידה. נחבלה חבלות שטחיות בלבד. בעלה מתאר שהיא קראה לו לעזרה אחרי שהתעוררה. הוא בדק לה סוכר בדם שהיה 234.

סימנים חיוניים בקבלתה- דופק 110 לחץ דם 92/58 סטורציה 95 ללא חום

בבדיקה גופנית- האזנה ללב ולריאות- ללא ממצא

אק"ג- סינוס טכיקרדיה ללא סימני איסכמיה

בדיקות דם :

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
CREATININE mg/dL	0.9	0.7-1.3
BUN mg/dL	42	5-25
WBC 10e3/µL	12500	4.0-11.0
HgB g/dL	10.2	אשה 11.7-15.5
Plt 10e3/µL	412	150-450

מה השלב הבא בברור ?

א. בדיקה רקטלית בשאלה של דימום ממערכת העיכול

ב. אקו לב בשאלה של AORTIC STENOSIS

ג. CT אנגיו של הריאות בחשד לתסחיף ריאתי

ד. אנמנזה מכוונת בחשד להתעמרות על ידי בעלה

25. בן 90, סובל מירידה קוגניטיבית על רקע דמנציה מתקדמת, סיעודי בתפקודו. התקבל למחלקת סיעוד מורכב להמשך טיפול בפצע לחץ:

תמונה מספר 4 .

הפצע מפריש בכמות קטנה.

מה הטיפול המתאים לפצע זה ?

א. הטריה כירורגית

ב. לקחת תרבית עמוקה מהפצע וטיפול אנטיביוטי לפי תשובה

ג. חבישה מסוג של FOAM (למשל פולימם)

ד. חבישה מסוג ג'ל אנזימתי (פלמינל)

26. בת 80, גרה בביתה עם מטפלת, זקוקה לעזרה ברוב צרכי ה- ADL , הלכה עם הליכון. ברקע ידוע על עצירות כרונית, מחלת פרקינסון, ירידה קוגניטיבית קלה. מאושפזת במחלקה גריאטרית עקב כאב בטן. בבדיקתה- בטן תפוחה, טימפנית.

צילום בטן – תמונה מספר 5

מה תמליץ בנוגע לטיפול בחולה (בנוסף לצום) לפי הסדר המקובל?

א. חוקן ניקוי-> תיקון הפרעה אלקטרוליטרית-> שתיית Polyethylene glycol ("מרוקן")

ב. חוקן ניקוי-> תיקון הפרעה אלקטרוליטרית-> דקומפרסיה אנדוסקופית

ג. Rectal Tube -> דקומפרסיה אנדוסקופית-> טיפול ב-Neostigmin ->תיקון הפרעות אלקטרוליטריות

ד. Rectal Tube ->תיקון הפרעות אלקטרוליטריות-> טיפול ב- Neostigmin -> דקומפרסיה אנדוסקופית

27. בן 82, היה גר בגפו עד לחודש האחרון, עבר לגור אצל הבת לאחר נפילה ואשפוז בשל קוצר נשימה שבו התגלה סרטן ריאות, עם גרורות לבלוטות לימפה מדיאסטינאליות.
אחרי קביעת staging של הסרטן, מה הוא השלב הבא?

א. אשפוז בשיקום גריאטרי לפני התחלת טיפול כימותרפי
ב. הפנייה לטיפול פליאטיבי לאיזון תסמינים
ג. ביצוע הערכה גריאטרית כוללנית
ד. התחלת טיפול כימותרפי לפי פרוטוקול מקובל

28. בן 78, מתגורר עם מטפל זר. ברקע סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, מצב לאחר אירוע מוחי איסכמי עם חולשת צד ימין קלה, דמנציה מתקדמת, נזקק לעזרה בכל צרכי ה-ADL.
אושפז במחלקה פנימית עקב אורוספסיס. בקבלתו לאשפוז HbA1C- 9.5%. הותחל טיפול ב- INSULIN.
בני המשפחה הודרכו לגבי טיפול באינסולין.
מה ההמלצות להמשך טיפול בסוכרת לפי המאמר Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes—2020?

א. סוכר בצום 90-130 מ"ג/ד"ל, יעד המוגלובין מסוכר מתחת ל-7.5%
ב. סוכר בצום 90-150 מ"ג/ד"ל, יעד המוגלובין מסוכר מתחת ל-8.0%
ג. סוכר בצום 100-180 מ"ג/ד"ל, יעד המוגלובין מסוכר מתחת ל-8.5%
ד. סוכר בצום 100-220 מ"ג/ד"ל, יעד המוגלובין מסוכרר מתחת ל- 9.5%

29. איזה מהמשפטים הבאים מתאר שיקול מתאים של התערבות טיפולית כתלות בתוחלת חיים צפויה?

א. אין תועלת לבדיקת גילוי מוקדם לסרטן המעי הגס אם תוחלת החיים הצפויה היא פחות מ- 10 שנים
ב. אין תועלת בטיפול בנוגדי דיכאון אם תוחלת החיים הצפויה היא פחות מחצי שנה
ג. אין תועלת בסטטינים למניעה שניונית של מחלה קרדיו-ווסקולרית אם תוחלת החיים הצפויה היא פחות מ- 5 שנים
ד. אין תועלת באיזון לחץ דם למניעה ראשונה של מחלה קרדיו-ווסקולרית אם תוחלת החיים הצפויה היא פחות מ- 5 שנים

30. בן 67 הסובל מהגדלה שפירה של הערמונית חזר לביקורת חצי שנה לאחר שהחל לקבל טיפול תרופתי לדחיפות במתן שתן (URGE INCONTINENCE). הוא מדווח על הפרעה חדשה בתפקוד המיני והופעת גניקומסטיה.
מה התרופה שגרמה לתופעות הלוואי המתוארות?

א. Tadafil (סיאליס)
ב. Finasteride (פרופסיה)
ג. Mirabegron (בטמיגא)
ד. Oxybutinin (נוביטרופן)

31. בן 85 התקבל למחלקה פנימית גריאטרית מאשפוז יום אונקולוגי עקב ירידה במצב ההכרה. ברקע TRANSITIONAL CELL CARCINOMA ממקור שלפוחית השתן במצב מפושט. לפני 4 חודשים הופסק טיפול אונקולוגי וטופל בביתו ב"הוספיס בית". בבדיקה גופנית- החולה שקוע, נראה סובל מאוד. בבדיקות הדם עליה בקריאטינין מ- 1.2 לפני חודש ל- 4.7 והיפרקלמיה – 7.2.
מה הגישה הטיפולית לפי חוק החולה הנוטה למות?

א. אם החולה מוגדר כחולה הנוטה למות ולא חולה במצב סופי חובה לטפל בהיפרקלמיה
ב. אם החולה מוגדר חולה נוטה למות במצב סופי ניתן לא לטפל בהיפרקלמיה
ג. ההחלטה הטיפולית מתקבלת לפי רצון המשפחה
ד. ההחלטה הטיפולית מתקבלת בעזרת תומך החלטה שמונה לחולה

32. בת 83, שמורה קוגניטיבית ועצמאית בתפקודה. ברקע ידוע על סוכרת ויתר לחץ דם. אושפזה לפני 3 ימים בשל דלקת ריאות, בקבלתה חום 39.2, סטורציה 86% באוויר חדר, 30 נשימות לדקה, דופק 150, לחץ דם 70/30. מטופלת ב –Ceftriaxone ו- Azithromycin מקבלתה, עם שיפור קליני ומעבדתי ניכר.
ביום הרביעי לטיפול מרגישה טוב יותר. סימנים חיוניים- חום 37.8, סטורציה 91% באוויר חדר, 18 נשימות לדקה, דופק 106, לחץ דם 120/80.
החולה מתלוננת על קושי בשהייה באשפוז ומבקשת להשתחרר לביתה בהקדם האפשרי.
מה ההמלצה הטיפולית?

א. היות ויש שיפור קליני ניתן לשחררה לביתה עם טיפול ב- Levofloxacin (טבניק) פומי
ב. לאור גילה של המטופלת ומחלות הרקע יש להשלים 7 ימים טיפול אנטיביוטי באשפוז ללא התייחסות לסימנים החיוניים
ג. עקב חום וטכיקרדיה מדובר בכישלון טיפולי ומומלץ לשקול שדרוג של הטיפול האנטיביוטי
ד. המשך החום והטכיקרדיה מהווים אינדיקציה להמשך טיפול אנטיביוטי באשפוז ואף שיקול להארכת משך הטיפול האנטיביוטי

33. מתוארים מטה ארבעה מטופלים, שסובלים מירידה תפקודית משמעותית סביב אשפוז. מי מהם הכי מתאים להתחלת שיקום כעת?

א. בת 77 שגרה עם בעלה, עצמאית טרם האשפוז. אושפזה עם שבר פרטרוכנטרי שתוקן ניתוחית לפני חמישה ימים. אובחנה הבוקר עם זיהום במפרק המנותח. מבצעת הוראות פשוטות במיטה, נראית עייפה
ב. בן 82, אלמן וגר בגפו. טרם האשפוז נזקק לעזרה בניקיון הבית והכנת אוכל. סובל מממאירות ערמונית. אושפז בשל שבר בפמור, שבעקבותיו אובחנו גרורות מפושטות לשלד. שיתוף פעולה חלקי בביקור, רושם שכאוב מאד
ג. בת 84 שגרה עם הבת. טרם האשפוז נזקקה לעזרה בלבוש פלג גוף תחתון ועזרה ברחצה. אושפזה בתמונה של שבץ איסכמי עם פלגיה מלאה מימין. באנמנזה והערכת ריפוי בעיסוק רושם לירידה קוגניטיבית עם MMSE של 23/30. בהערכה לשיקום היא מבצעת הוראות פשוטות, אך מתקשה עם הוראות מורכבות
ד. בן 75 גר עם אשתו, ברקע ירידה קוגניטיבית קלה ביותר. עצמאי בתפקוד. אושפז לצורך ניתוח אלקטיבי לכריתת מעי בשל גידול שבוצע לפני שבוע. מאז הניתוח אירועים לסירוגין שבהם לא מתמצא ולא מזהה את בני המשפחה ונראה מבולבל. בשאר הזמן הוא מדבר לעניין. בהערכה לשיקום – התמצאות לקויה, קשב ירוד

34. איזה אביזר עזר מתאים לאיזו הפרעת הליכה?

א. חולה הסובל מהמיפרזיס ברגל ימין – קוודריפוד ביד שמאל
ב. חולה הסובל מורטיגו – מקל הליכה
ג. חולה עם דמנציה- כיסא גלגלים ממנוע
ד. חולה פרקינסון מתקדם – רולטור

35. בת 83 , עצמאית בתפקודה, פנתה למחלקה לרפואה דחופה עקב נפילה בביתה ללא איבוד הכרה. לדבריה קמה בלילה משינה, הלכה בבית ונתקלה בשטיח. אובחן שבר ברדיוס. השבר קובע והיא שוחררה לביתה.
מה ההתערבות שהוכחה כיעילה למניעת נפילות בעתיד?

א. שדרוג המשקפיים למולטיפוקל
ב. הליכה עם הליכון בלבד
ג. החלפת כדורי שינה מ- BROTIZOLAM (בונדורמין) ל- ZOLPIDEM (סטילנוקס)
ד. בדיקת הבית על ידי מרפאה בעיסוק

36. בן 80 , מתגורר בביתו עם אשתו. ברקע מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, סוכרת מסוג 2 מאוזנת.

הופנה לבדיקת רופא גריאטר בשל ירידה בזיכרון, אי שקט, אלימות מילולית ופיזית כלפי הסובבים.

לפי אנמנזה מבני משפחתו: לפני כשלוש שנים הופיעה ירידה בזיכרון לטווח הקצר אשר התבטאה בעיקר בשכיחת תאריך, יום בשבוע, חזרה על אותן שאלות וחיפוש חפצים שלא זכר היכן הניח.

בשנה האחרונה נצפתה ירידה הדרגתית נוספת בזיכרון כולל בזיכרון לטווח הארוך, הופעת קושי בשימוש במכשירי הבית, אירועי הליכה לאיבוד ביציאה מהבית. במקביל חל שינוי באישיותו -הפך להיות אפתי, אדיש ולעתים קרובות אלים .

בתפקודיו הבסיסיים זקוק לתזכורת להתקלח ועזרה בהתאמת הבגדים.

בבדיקתו: בהכרה מלאה. קשב וריכוז תקינים. בשיחה טוען שאין לו כל בעיה קוגניטיבית.

בדיקה גופנית כולל נוירולוגית ללא ממצא בולט.

במבחן MMSE שיתף פעולה וצבר 16 נקודות.

איזה מהממצאים הבאים צפוי להיות בבדיקות נוספות של מטופל זה?

א. במבחן GDS יקבל תוצאה של 11
ב. בנוזל ספינלי צפויה עליה באמילויד בטא וב- TAU
ג. בבדיקת MRI מוח צפויים שינויים איסכמיים כרוניים
ד. EMG ידגים איטיות של גלי GAMMA

37. בת 69 התקבלה לאשפוז במחלקה פנימית גריאטרית עם כאבים בחזה וכאבים במפרקים שורש כף יד ימין וכתף שמאל.

ברקע: יתר לחץ דם עקשני- טופלה ב- ATENOLOL (נורמיטן) ו- VALSARTAN (דיובן).

לפני חודש הוחל מתן HYDRALAZINE .

בבדיקה גופנית רושם לשיפשוף פריקרדיאלי.

אק"ג- תמונה מספר 6.

מהי אבחנה הסבירה ביותר?

א. DERMATOMYOSITIS
ב. SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS
ג. POLYMIALGIA RHEUMATICA
ד. FELTY SYNDROME

38. בן 68, מזה מספר חודשים מתלונן על כאבי גב תחתון שמופיעים בעמידה ממושכת ובהליכה, מוקלים בישיבה ובכיפוף קדימה.
במסגרת הבירור בוצע MRI של עמוד השדרה המתני – **תמונה מספר 7 .**
מה מהבאים הוא הגורם השכיח ביותר לפתולוגיה הנרכשת המתוארת ?

א. Ankylosing spondylitis
ב. אוסטיאוארתריטיס (Degenerative Arthritis)
ג. מחלת פאג'ט של העצם (Paget disease of bone)
ד. דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid arthritis)

39. בן 88 סובל מ-ALZHEIMER DISEASE. בשנה האחרונה המטופל התעלף פעמיים במהלך היום. בוצע הולטר אק"ג שהדגים נטייה לברדיקרדיה בלילה.
מכל התרופות האפשריות לטיפול בדמנציה איזו תרופה אינה מומלצת למטופל זה?

א. DONEPEZIL (ממוריט)
ב. RIVASTIGMINE (אקסלון)
ג. GALANTAMINE (גלנטמינה)
ד. MEMANTINE (ממוקס)

40. מה מהשינויים הבאים אופייני להזדקנות נורמלית של הריאה?

א. ירידה ב- Residual volume (RV)
ב. עליה ב- (diffusion lung capacity for carbon monoxide (DLCO
ג. עליה ב- Functional residual capacity (FRC)
ד. ירידה ב- Residual Volume (RV)

41. איזו מבין התרופות נוגדות דיכאון הבאות עשויה לגרום להפרעת הקצב באק"ג **בתמונה מספר 8?**

א. Citralopam (ציפרמיל)
ב. Duloxetine (סימבלטה)
ג. Bupropion Hydrobromide (וולבוטרין)
ד. Hypericum perforatum (רמוטיב)

42. לאיזו מהתרופות הבאות יש השפעה אנטיכולינרגית חזקה ביותר?

א. OLANZAPINE (זיפרקסה)
ב. RISPERIDONE (ריספרדל)
ג. QUETIAPINE (סרוקוול)
ד. HALOPERIDOL

43. מה מבין השינויים הפסיכולוגיים/ קוגניטיביים הבאים נחשב בשינוי של הזדקנות נורמלית?

א. ירידה באוצר המילים
ב. נטייה להיות מושפע מרושם ראשוני
ג. התחזקות באמונה דתית
ד. נטייה להתבודדות

44. בן 65, מגיע למיון עם חולשה כללית, סחרחורת מאתמול. אשתו מתארת איבוד המוטיבציה ואיבוד היכולת ליזום פעולות מונחות מטרה, לקבוע מטרות ולהחליט החלטות, ואובדן שליטה על סוגר השתן . בבדיקה נוירולוגית- חולשה בגפיים התחתונות עם סימנים פירמידליים, ללא הפרעה בעצבי הגולגולת.
איזו תסמונת מתארת את השבץ האיסכמי ממנו סובל מטופל זה?

א. Anterior Cerebral Artery Infarction
ב. Middle Cerebral Artery Infarction
ג. Posterior Cerebral Artery Infarction
ד. Posterior inferior cerebellar arteries

45. בן 72 , סובל ממחלת פרקינסון כ-7 שנים. למטופל תגובה טובה לטיפול ב- Dopicar, הבאה לידי ביטוי בשיפור ניכר בתפקוד המוטורי. יחד עם זאת בזמן שמתפקד היטב ישנן תנועות לא רצוניות מרובות (Peak dose Dyskinesias) הפוגעות באופן קשה באיכות חייו של המטופל.
איזו מבין הגישות הטיפוליות הבאות יכולה להקל על המטופל לשמור על התפקוד היום יומי ובמקביל להפחית את התנועות הלא רצוניות ?

א. פיזיותרפיה מכוונת לשעות של הדיסקינזיות
ב. עליה במינון ה Dopicar
ג. הפסקת הטיפול ב Dopicar
ד. מתן רציף של Levodopa/carbidopa בעזרת משאבה ישירות למעי

46. על פי המאמר Advanced dementia מאת Mitchell, מהם הסיבוכים הקליניים השכיחים ביותר בדמנציה מתקדמת?

א. הפרעות הליכה ואפתיה
ב. הפרעות שינה והתפתחות פצעי לחץ
ג. הפרעות אכילה וזיהומים
ד. דיכאון ואי שליטה על סוגרים

47. בת 89, בעלת תואר שני במדעים. פנתה לבירור בשל תלונות על מצב רוח ירוד, תחושת ריקנות, בדידות ועיסוק רב במחשבות על בעלה שנפטר לפני כשבועיים בהיותו מאושפז על רקע דלקת ראות.
מה מהבאים מהווה גורם סיכון להתפתחות Persistent complex bereavement disorder בקרב המטופלת?

א. השכלתה האקדמית
ב. היותה אישה
ג. היעדר רקע של הפרעת חרדה או דכאון
ד. מותו של בעלה לאחר מחלה ממושכת

48. מה המשפט המתאר את הסיכון לשברים בחוליות בחולים עם אוסטאופורוזיס?

א. שבר קודם בגולגולת, אך לא בעצמות האף, מהווה גורם סיכון לשבר נוסף
ב. צפיפות עצם אינה מנבאת את הסיכון לשבר בחוליה בגברים
ג. שבר קודם בחוליה מהווה גורם סיכון לשבר נוסף
ד. עודף משקל מעלה את הסיכון לשבר בחוליה

49. בת 67, הגיעה לבדיקה במרפאה בשל תלונות על ירידה בזיכרון. מדווחת על היסטוריה משפחתית של אמא שחלתה במחלת אלצהיימר כשהייתה בת 85.
באבחון MMSE קיבלה 29/30 ובאבחון MOCA קיבלה 28/30. בדיקת ציור שעון תקינה.
שני ילדיה שליוו אותה לבדיקה, טוענים שהיא עובדת המון שעות ביממה בעבודה משרדית, מעשנת קופסת סיגריות ביום ושותה 2-3 פחיות בירה בערב. היא עצבנית, מתקשה להירדם ועייפה רב הזמן.
מתוך המאמר Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report מאת Livingston ושותפיו מה ניתן להדריך מטופלת זו למניעת דמנציה?

א. תרגול קוגניטיבי יומיומי הוכח כמונע התקדמות MCI לדמנציה
ב. הפסקת עישון גם בגיל מאוחר יכולה להוריד את הסיכון לדמנציה
ג. טיפול תרופתי להשגת שינה איכותית יכול להוריד את הסיכון להתפתחות דמנציה
ד. לצורך "ניטרול" גורם הסיכון של שתית אלכוהול יש להפסיק לחלוטין את השתיה ולא רק להפחית כמויות

50. מה המשפט המתאר בצורה נכונה את הטיפול בהתקף GOUT בקשישים?

א. טיפול בסטרואידים בפוליארטיקולר גאוט ניתן ל-10-5 ימים עם ירידה הדרגתית (tapering)
ב. טיפול ב- colchicine ניתן במינון 0.5 מ"ג 4 פעמים ביום ומופחת במקרה של שלשול
ג. febuxostat (פבוריק) עדיפה על allopurinol בחולה עם מחלת לב איסכמית
ד. NSADIS לא סלקטיביים הוכחו כיעילים יותר מ- NSAIDS סלקטיביים בטיפול בגאוט

51. לפי מחקרים בבעלי חיים, הדיאטה המביאה לתוחלת החיים הארוכה ביותר, היא דיאטה שבה יש הגבלה בכמות של –

א. חלבון
ב. פחמימות
ג. שומנים
ד. שומנים ופחמימות

52. בן 75, מאובחן עם דיכאון. מזה שבועיים מקבל טיפול של ESCITALOPRAM במינון 5 מ"ג. מדווח על שיפור מסוים במצב הרוח, אך עדיין מתקשה בשינה ומרגיש חוסר אנרגיה. מה **נכון** להמליץ במצב זה?

א. להחליף טיפול ל- MIRTAZAPINE במינון 15 מ"ג
ב. להמשיך טיפול ב- ESCITALOPRAM במינון 5 מ"ג והוסיף MIRTAZAPINE במינון 15 מ"ג
ג. להוסיף טיפול ב- QUETIAPINE במינון 12.5 מ"ג
ד. להעלות מינון ESCITALOPRAM ל- 10 מ"ג

53. בן 70, עצמאי וללא ירידה קוגניטיבית, ברקע יתר לחץ דם וסוכרת, מאוזנים, התקבל למחלקה כירורגית עקב חסימת מעיים. עלה למחלקה בשעה 23:00 בלילה לאחר שהיה של 24 שעות במחלקה לרפואה דחופה. בקבלתו באי שקט פסיכומוטורי, לא מתמצא במקום ובזמן. לפי CAM המטופל אובחן עם דליריום.
הכירורגים מעוניינים לקבל הסכמה של המטופל לניתוח שיבוצע בימים הקרובים במידה ולא ישתפר בטיפול שמרני.
מה הגישה המתאימה לקבלת הסכמה לניתוח למטופל זה?

א. כדאי לנסות לדבר עם המטופל בבוקר. יתכן ויהיה שיפור במצבו ויהיה כשיר לחתימה
ב. יש למלא תעודת רופא ולמנות אפוטרופוס בן משפחה
ג. מומלץ לבצע בדיקת MINI-COG להערכת מצבו הקוגניטיבי
ד. מומלץ להתחיל טיפול תרופתי באנטי פסיכוטים לצורך שיפור מצבו הקוגניטיבי ואז ניתן יהיה לקבל הסכמה

54. חסימה של איזה עורק יכולה לגרום ל"תסמונת נעילה" (LOCKED-IN) ?

א. Anterior communicating artery
ב. Anterior choroidal artery
ג. Posterior inferior cerebellar arteries
ד. Basilar artery

55. בת 84, אושפזה עקב פרפור עליות התקפי וקוצר נשימה.
ברקע- יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, סוכרת, CARPAL TUNNEL SYNDROME.
בדיקת אקו לב הדגימה EF 40% . בדיקת BNP - 88 (בתחום התקין)
איזה נתון בתיאור המקרה יכול להחשיד שיש לה CARDIAC AMYLOIDOSIS?

א. ממצא של EJECTION FRACTION 40% באקו
ב. היותה אישה
ג. CARPAL TUNNEL SYNDROME
ד. חוסר עליה של BNP

56. בן 76 הסובל מיתר לחץ דם.
מה הטיפול התרופתי המתאים על פי הרקע הרפואי שלו?

א. סוכרת- BETA BLOCKERS
ב. אי ספיקת כליות כרונית- DIURETICS
ג. אי ספיקת לב- CALCIUM CHANNEL BLOCKERS
ד. מצב לאחר אוטם שריר הלב - ANGIOTENSIN COVERTIN ENZYME INHIBITORS

57. איזה מהמשפטים הבאים לגבי פרוגנוזה של דלירים **נכון**?

א. נוכחות דלירים באשפוז מעלה סיכון לתמותה בשנה לאחר האשפוז
ב. דלירים היפראקטיבי כרוך בפרוגנוזה גרועה יותר
ג. ברוב החולים המאושפזים הדלירים חולף תוך מספר ימים
ד. דלירים באשפוז מהווה גורם סיכון להעברה למוסד רק במטופלים עם רקע של דמנציה

58. מטופל מתגורר בבי"ח גריאטרי סיעודי וזקוק כעת למכשיר שמיעה. באחריות מי מהבאים לממן זאת?

א. קופת החולים
ב. משרד הבריאות
ג. המוסד הסיעודי בו מתגורר
ד. המטופל או משפחתו

59. בן 82, עצמאי בתפקודו שמור קוגניטיבית, במעקב במרפאה נפרולוגית עקב אי ספיקה כלייתית כרונית יציבה. ללא פרוטאינוריה.

בבדיקות הדם:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	4.9	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	2.1	0.7-1.3
BUN mg/dL	28	5-25
WBC 10e3/µL	8700	4.0-11.0
HgB g/dL	11.1	13.2-17 גבר
Plt 10e3/µL	276000	150-450
Iron ng/mL	38	40-150
Transferrin mg/dL	126	220-400
Ferritin ng/mL	354	14-163
Vitamin B12 pg/mL	437	175-961
Folic Acid ng/mL	5.6	2.6-17.1

מה הגישה הנכונה לברור וטיפול באנמיה?

א. למטופל אנמיה משנית לאי ספיקה כלייתית ומומלץ להתחיל טיפול בתכשיר אריתרופוייטין

ב. למטופל אנמיה מחסר ברזל ומומלץ טיפול בברזל תוך ורידי

ג. למטופל אנמיה משנית לאי ספיקה כלייתית ואין צורך בטיפול תרופתי בשלב זה

ד. יש צורך בהמשך ברור אנמיה על ידי בדיקת מח עצם

60. בת 85, מגיעה למיון לאחר שבר בצוואר הירך בליווי הבת שלה. אילו מהתסמינים הבאים יעוררו חשד גבוה להתעמרות נפשית במטופלת?

א. במעבר על גיליונות קודמים מסתבר שזו הפעם השלישית שמגיעה בעקבות שבר למיון
ב. במעבר על תיק קופת החולים מסתבר שאינה רוכשת כמחצית מהתרופות הכרוניות שניתנו לה במרשם
ג. בבדיקות המעבדה קריאטנין ו-BUN מוגברים באופן אקוטי
ד. בשיחה עם המטופלת היא מסרבת לענות על שאלות כאשר הבת שלה נמצאת בחדר

61. בן 88 הסובל מדמנציה מתקדמת מאושפז במחלקה לסיעוד מורכב עקב פצע לחץ המופיע **בתמונה מספר 9 .**
מה כוללות ההמלצות התזונתיות בחולה זה?

א. כלכלה עשירה בחומצות שומן קצרות
ב. כלכלה עם 20 קילוקלוריות/ק"ג
ג. העשרת חלבון 1.25-1.5 גרם/ק"ג
ד. מתן תוספי ויטמין ומינרלים כמו ויטמין E ו- SELENIUM

62. מהם שינוים הנחשבים בגבולות הנורמה במערכת קרדיו-ווסקולרית בקשישים?

א. התפתחות של Valvular Regurgitation
ב. ירידה במשקל הלב
ג. הופעה של ציר ימני באק"ג
ד. ירידה ב Pulse Pressure

63. מה **נכון** לגבי אוכלוסיית בני ה- 85 בישראל לפי לקט הנתונים של מכון ברוקדייל?

א. מעל 50% מהם מקבלים עזרה מ"חוק סיעוד"
ב. 20% מתוכם נמצאים במוסדות
ג. 20% מהם מתקשים בהליכה או בעליית מדרגות
ד. בגיל זה יותר גברים מנשים נזקקים לעזרה מ"חוק סיעוד"

64. מה מאפיין את השינויים בכליות בגיל המבוגר?

א. יש עליה בהתנגדות של עורקי ה- afferent וירידה בהתנגדות של עורקי ה- efferent
ב. בכ- 2/3 מהאוכלוסייה נצפית ירידה בתפקודי כליה עם הגיל
ג. עקב נפרוסקלרוזיס יש עליה במסת הכליות עם הגיל
ד. פרוטינוריה עד 200 מ"ג/24 שעות נחשבת לתקינה בבני 70 ומעלה

65. מה מאפיין את השינויים בלבלב בגיל המבוגר ?

א. יש ירידה בתפקוד האקסוקריני של הלבלב
ב. יש עליה בנפח הלבלב משני להסננה שומנית
ג. יש עליה בלחץ של ה- SPHINCTER OF ODI
ד. יש ירידה במשקל הלבלב

66. בת 75 התאשפזה לאחרונה עקב בצקת ריאה על רקע אי ספיקת לב עם EF- 30%, משנית למחלת לב איסכמית. גורמי סיכון: סוכרת, היפרליפידמיה, יתר לחץ דם אך אינה מעשנת. הטיפול התרופתי הקבוע כולל VALSARTAN, PROPRANOLOL, ASPIRIN, METFORMIN, FUROSEMIDE.
אילו המלצות טיפול מתאימות לחולה הזאת?

א. הגבלת שתיה ל- 4 כוסות ליממה, הוספת טיפול ב- SPIRONOLACTONE ומעקב רמות אשלגן
ב. הגבלת שתיה ל- 8 כוסות ליממה, החלפת ה- PROPRANOLOL ב-CARVEDILOL
ג. הגבלת צריכת מלח עד 1 גרם ליממה והימנעות מביצוע מאמצים
ד. התחלת טיפול ביתי בעירוי FUROSEMIDE שלוש פעמים בשבוע

67. ארבעה מטופלים עצמאיים בתפקודם ושמורים קוגניטיבית הגיעו למרפאה עם תשובת כולסטרול LDL – 160. שלושה מהם זקוקים לטיפול בסטטינים ואחד לא.
איזה מהמטופלים הבאים **אינו זקוק** לטיפול בסטטינים?

א. בן 86, ברקע יתר לחץ דם ועישון
ב. בת 89 לאחר אוטם והכנסת תומכן
ג. בן 75, עם סוכרת מאוזנת
ד. בת 79, עם PVD

68. בן 75, ללא מחלות רקע, נפל ושבר את הירך. עבר קיבוע ניתוחי.
בבדיקות הדם בקבלה למחלקת שיקום:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
WBC 10e3/µL	9.8	4.0-11.0
HgB g/dL	8.5	13.2-17 גבר
MCV fL	88	80-96
Plt 10e3/µL	187	150-450
Iron ng/mL	52	40-150
Transferrin mg/dL	250	220-400
Ferritin ng/mL	145	14-163
Vitamin B12 pg/mL	526	175-961
Folic Acid ng/mL	15	2.6-17.1
CREATININE mg/dL	1.0	0.7-1.3
BUN mg/dL	26	5-25

מה הסיבה הכי סבירה לאנמיה אצל המטופל הזה?

א. אנמיה של Myelodysplastic Syndrome
ב. אנמיה של מחלה כרונית
ג. אנמיה פוסט ניתוחית
ד. אנמיה של חסר ברזל

69. בת 82 עצמאית ושמורה קוגניטיבית, גרה בקהילה. ברקע סוכרת מאוזנת.
בשל בצקות קלות ברגליים, נלקח בקופת חולים סטיק שתן שהדגים חלבון +, סוכר + , ניטריטים + , לויקוציטים ++ ואריתרוציטים ++.
החולה שוללת תכיפות או דחיפות במתן שתן, צריבה בשתן, חום או כאבי מותניים. בסונר כליות ודרכי שתן עולה חשד לגוש בשלפוחית השתן.
באיזה מצב יש לקחת תרבית שתן ממטופלת זו?

א. לצורך זיהוי חיידק למקרה של צורך בטיפול אנטיביוטי בעתיד
ב. לצורך טיפול בזיהום בדרכי השתן בחולת סוכרת
ג. אם החולה מועמדת לציסטוסקופיה
ד. אם החולה מועמדת להכנסת קתטר

70. מה מאפיין את השינויים במערכת השתן בגיל המבוגר?

א. רוב הקשישים עם אי שליטה על שתן סובלים מהתכווצויות לא רצוניות של השלפוחית (involuntary bladder contractions)
ב. שאריות שתן לאחר ריקון (residual urine volume) יורדת עם הגיל
ג. קיבולת השלפוחית (functional bladder capacity) עולה עם הגיל
ד. בנשים בנות 80 ומעלה יש עליה בסיכון לאי שליטה על שתן ככל שעברו יותר לידות

71. פולימורפיזם במספר גנים הוכח כקשור להארכת חיים.
איזה גן מהגנים הבאים **לא הוכח** כקשור להארכת חיים?

א. FOXO3A
ב. APOE
ג. SIRT3
ד. KITLG

72. מה מהבאים מהווה קריטריון לאבחנה/ קלסיפיקציה של - GIANT CELL ARTERITIS לפי – ACR CLASSIFICATION CRITERIA – 1990?

א. ממצאים בביופסיה של העורק הטמפורלי עם הסננת תאים פולינוקלארים
ב. CRP מוגבר פי 3 מהנורמה
ג. לויקופניה
ד. רגישות במישוש סביב העורק הטמפורלי

73 . בן 87, עצמאי בתפקודו . ברקע יתר לחץ דם, סוכרת והיפרליפידמיה. עקב זיהום בדרכי הנשימה העליונות מטופל ב- Cefuroxime (זינט) מזה שבוע. פנה למחלקה לרפואה דחופה בשל אירועי שלשול וכאבי בטן מזה כיומיים. בבדיקתו נראה במצב כללי טוב, יציב המודינמית ונשימתית, חום סיסטמי תקין. בדיקת Clostridium Difficile toxin חיובית. מהי הגישה הטיפולית המתאימה?

א. הפסקת הטיפול האנטיביוטי שגרם למחלה יספיק ברוב החולים במצב יציב וניתן לעקוב ללא טיפול
ב. מומלץ להתחיל טיפול ב- VANCOMYCIN פומי
ג. מומלץ להתחיל טיפול ב- METRONIDAZOLE (פלג'יל) תוך ורידי
ד. מומלץ להתחיל טיפול ב- VANCOMYCIN פומי יחד עם METRONIDAZOLE (פלג'יל) תוך ורידי

74. איזה מהחיסונים הבאים מומלץ <u>רק לקשישים עם גורמי סיכון</u> ולא לכל הקשישים ?

א. חיסון לשפעת (INFLUENZA)
ב. חיסון לזיהום על ידי PNEUMOCOCOCUS
ג. חיסון לזיהום על ידי MENINGOCOCOCUS
ד. חיסון לשלבקת חוגרת (VARICELLA ZOSTER)

75. בן 75 עצמאי בתפקודו ושמור קוגניטיבית. ברקע יתר לחץ דם ומחלת לב איסכמית יציבה. אובחן כסובל מקרצינומה של הערמונית עם גרורות לעצמות. הומלץ לו על טיפול androgen-deprivation therapy בזריקות GNRH ואנטי אנדרוגן.
מה חשוב להדריך אותו לגבי טיפול זה?

א. הטיפול יכול להביא להחלמה מלאה בערך ב- 50% מהחולים
ב. הטיפול יכול להעלות סיכון לדמנציה
ג. הטיפול יכול לגרום לירידה בלחץ הדם
ד. הטיפול יכול לגרום לפוליציטמיה משנית

76. מה **נכון** לגבי טיפול לא תרופתי בקוצר נשימה בסוף החיים ?

א. במחקר שהשווה מתן אויר לעומת חמצן דרך משקפים (nasal cannula) לחולים עם סטורציה תקינה, נמצא יתרון משמעותי למתן חמצן
ב. טיפול בהנשמה לא פולשנית מסוג BiPAP אינו מומלץ לחולי COPD בדרגה מתקדמת
ג. טיפול בחמצן לחולי COPD עם ירידה בריווי חמצן משפר איכות חיים ומאריך חיים
ד. בחולים אונקולוגים לא נמצא יתרון בשיפור איכות חיים בטיפול בהנשמה לא פולשנית

77. בת 80 המטופלת ב- CITALOPAM הגיעה להתייעץ לגבי מינון התרופה. היא מטופלת ב- 20 מ"ג של CITALOPRAM בשיפור חלקי ומבקשת לעלות את מינון התרופה.
מה ההסבר להגבלת מינון של CITALOPRAM בגיל מבוגר?

א. מינון גבוה של התרופה יכולה לגרום לעלייה בערכי לחץ דם
ב. מינון גבוה של התרופה יכול לגרום לאגירת נוזלים והגברת תאבון
ג. מינון גבוה יכול לגרום להפרעת קצב
ד. עלית במינון של התרופה מעלה סיכון לשבר

78. בת 72, עצמאית בתפקודה וללא חסר קוגניטיבי פנתה למרפאה עקב כאבי עצמות משניים לגרורות מקרצינומה של הריאה. היא טופלה בבית ב- PARACETAMOL ו- DIPYRONE (אופטלגין) ללא הטבה. הוחלט על התחלת טיפול באופיואידים.
מה יש להדריך אותה עם התחלת הטיפול?

א. הטיפול גורם לעצירות אך יש סבילות (tolerance) שמתפתחת אחרי מספר ימים
ב. הטיפול גורם לבחילות אך יש סבילות (tolerance) שמתפתחת אחרי מספר ימים
ג. יש להימנע מנהיגה כל התקופה בה מטופלת באופיואידים
ד. אם מגיעים למינון מקסימלי של תרופה אופיואידית יהיה צורך לעבור לתכשיר אחר

79. איזו מהתרופות הבאות יכולה לגרום לירידה בתיאבון?

א. Levetiracetam (קפרא)
ב. Olanzapine (זיפרקסה)
ג. Empagliflozin (ג'רדיאנס)
ד. Oxazepam (ואבן)

80. מה המשפט שמתאר בצורה נכונה השפעה של ויטמינים ומינרלים על מחלות שונות?

א. תוספת ויטמין B12 מעכבת הופעת age-related macular degeneration (AMD)
ב. תוספת ויטמין E מורידה שכיחות של שבץ
ג. תוספת ויטמין B1 (תיאמין) יכולה לעזור בחולי אי ספיקת לב תחת טיפול משתן
ד. תוספת ויטמין D יכולה לעזור במניעה של פצעי לחץ בחולים במוסדות

81. כל התופעות הבאות הן תופעת לוואי של PPI – Proton Pump Inhibitor **פרט ל-**

א. החמרת COPD
ב. אי ספיקה כלייתית
ג. זיהום ב- Clostridium difficile
ד. שברים בעצמות

82. איזה גורמים משפיעים על תמותה לאחר שבר בצוואר הירך לפי המאמר Management of Acute Hip Fracture מאת Bhandari ?

א. ניתוח תוך פחות מ- 24 שעות מפחית את התמותה לאחר שבר

ב. ביצוע קיבוע עם intramedullary nails משפר את הפרוגנוזה לעומת ביצוע קיבוע חיצוני

ג. חולים שלא נותחו ונשארו במיטה נותרו במצב סיעודי אך ללא השפעה על אחוזי התמותה

ד. מתן של ביספוספונטים בחודש הראשון לאחר השבר הראה עליה בסיכון לתמותה

83. מה הוא ביטוי אפשרי של אירוע מוחי בטריטוריה של Middle Cerebral Artery ?

א. ירידה סנסורית איפסילטרלית

ב. Aphasia אם האירוע הוא בהמיספירה שמאלית

ג. homonymous hemianopsia איפסילטרלית

ד. Diplopia

84. לפי MCKEITH CRITERIA לאבחנת DEMENTIA WITH LEWY BODIES, איזה מהבאים **<u>אינו</u>** CORE FEATURE?

א. פלקטואציות בערנות ובריכוז

ב. הזיות ויזואליות חוזרות

ג. מחשבות שווא סיסטמיות

ד. פרקינסוניזם ספונטאני

85. בן 76, הגיע למרפאה קוגניטיבית לצורך הערכה בשל ירידה בזיכרון, נפילות חוזרות ונטייה לאי שקט בלילות. המשפחה מספרת על ירידה בזיכרון בחודשים האחרונים, בלבול בימי השבוע, בלבול בין שמות הנכדים. היה מקרה שחשד שאחד הנכדים הינו פורץ לביתו וצלצל למשטרה. פעמיים יצא מהבית סביב 3 בבוקר ללכת לקניות בסופר. לדברי המשפחה "יש ימים רעים ויש ימים טובים יותר". בבדיקה נוירולוגית- ריגידיות סימטרית בגפיים. לפני כשבוע נבדק במחלקה לרפואה דחופה בשל בלבול. בדיקות דם היו תקינות, ב -CT ללא עדות לאירוע חריף, עם שינויים כרוניים איסכמיים קלים. שוחרר ללא אבחנה ברורה.
אילו נתונים נוספים נדרשים על מנת להגיע לאבחנה?

א. MRI מח, בכדי להבדיל בין סוגי דמנציה שונים
ב. מיפוי PET לצורך אבחנה של דמנציה פרוטוטמפורלית
ג. מעבדת שינה בשאלה של הפרעה בשנת REM
ד. אין צורך בבדיקות נוספות, הנתונים הקליניים מספיקים לאבחנה של DEMENTIA WITH LEWY BODIES

86. מה המשפט המתאר בצורה נכונה את יעילות טיפולים לא תרופתיים באוסטאוארטריטיס?

א. ירידה במשקל עוזרת רק בירידה של מעל 10% מהמשקל
ב. קירור מקומי עם קרח יעיל בהפחתת כאב ודלקת אם הטיפול נמשך 30 דקות לפחות בכל פעם
ג. יש להדריך את החולה להשתמש במקל הליכה ביד של אותו צד של הרגל הפגועה
ד. שימוש בסד ברך (knee brace) מייצב את הברך ומונע נפילות

87. מה מתאר את הקשר בין דיכאון לשבר בצוואר הירך?

א. הדיכאון נמשך בדרך כלל כשנה אחרי השבר
ב. אין קשר בן קיום דיכאון למצב התפקודי
ג. דיכאון הוא אחד הגורמים המאטים את קצב השיקום
ד. היות ומדובר בדיכאון תגובתי לא מומלץ לתת טיפול תרופתי

88. בן 78, אובחן עם דיכאון מג'ורי לראשונה בחייו. ברקע אי ספיקת לב (NYHA II), Mild Cognitive Impairment (MCI), יתר לחץ דם, נוירופתיה והגדלה שפירה של הערמונית.
מה מהבאים **נכון** באשר לשיקולים לבחירת טיפול תרופתי?

א. יש עדיפות למתן Citalopram על פני Paroxetine בשל הסיכון להשפעה אנטיכולינרגית
ב. יש עדיפות למתן Mirtazapine על פני Bupropion (Wellbutrin) בשל הסיכון לפגיעה בתפקוד המיני
ג. יש עדיפות למתן Citalopram על פני Escitalopram בשל הסיכון להיפונתרמיה
ד. יש עדיפות למתן Citalopram על פני Mirtazapine בשל הסיכון לאריתמיה

89. בן 65, אובחן לאחרונה כסובל ממחלת פרקינסון והחל לקבל טיפול תרופתי. לטיפול השפעה מיטיבה על האיטיות והנוקשות. מאז התחלת הטיפול החל לסבול מאירועים בהם נרדם במשך היום, כולל בזמן נהיגה . כמו כן התחיל, לראשונה בחייו, לבקר בבתי קזינו ולהמר בסכומי כסף גדולים. מרבה לקנות חפצים שלא נזקק להם.
ככל הנראה הטיפול שהמטופל מקבל הוא -

א. Dopicar
ב. Ropinirole (רופינידול) -דופמין אגוניסט
ג. Amantadine (PK- merz)
ד. Rasageline (אזילקט) - מעכב MAO-B

90. בת 82, ללא ירידה קוגניטיבית ידועה, סובלת מקרצינומה של הריאה עם גרורות לעצמות ומטופלת בביתה במדבקת FENTANYL. לדברי משפחתה הכאבים מאוזנים ולא בוצע שינוי בתרופות לאחרונה. הגיעה למחלקה לרפואה דחופה עקב בלבול חדש. אובחנה כסובלת מדליריום.
מה הגישה האבחנתית הנכונה?

א. בדיקת דם לרמת סידן בדם
ב. בדיקת טוקסיקולוגיה בשתן
ג. מדובר ב- terminal delirium ואין צורך בברור
ד. כדאי להפסיק FENTANYL ולראות אם הדליריום משתפר

91. מי מהחולים הבאים נמצא בסיכון הגבוה ביותר לפתח CVA ב- 3 חודשים אחרי TIA לפי ABCD2 Score?

א. בן 70, ברקע יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, לחץ דם 138/88, שבמהלך האירוע הייתה לו הפרעה בדיבור ללא חולשת צד שחלפה לאחר 50 דקות
ב. בן 62, ברקע מחלת ריאות חסימתית, סוכרת ולחץ דם, לחצי דם 148/90, שבמהלך האירוע הייתה לו חולשה קלה בצד ימין שחלפה לאחר שעה
ג. בן 75, ברקע מחלת ריאות כרונית, יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, לחצי דם 150/80, שבמהלך האירוע הייתה לו הפרעה בדיבור שחלפה לאחר 30 דקות
ד. בן 90, ברקע יתר לחץ דם, לחצי דם 130/70 , שבמהלך האירוע הייתה לו חולשה קלה מצד שמאל שחפלה אחרי שעתיים

92. מה כוללת התכנית למניעת פצעי לחץ לחולה סיעודי המאושפז במחלקה פנימית עקב SEPSIS ?

א. הימנעות מהושבה של המטופל
ב. שימוש במזרן דינמי
ג. שינויי תנוחה פעם במשמרת
ד. הרמת ראש המיטה ל-°45

93. בת 88 תשושה בתפקודה עם ירידה קוגניטיבית קלה. שוקלת 70 ק"ג . מתגוררת במחלקה לתשושים. ברקע- CHRONIC LYMPHATIC LEUKEMIA ללא טיפול תרופתי. ללא אי ספיקה כלייתית.
אושפזה בבית חולים עם HERPES ZOSTER המופיע בתמונה 10.

מהו הגישה הטיפולית **הנכונה**?

א. טיפול ב- Acyclovir (זובירקס) פומי במינון 800 מ"ג 5 פעמים ביום
ב. טיפול ב- Valacyclovir (ולטרקס) פומי במינון 1000 מ"ג 3 פעמים ביום
ג. טיפול ב- Acyclovir תוך ורידי במינון 700 מ"ג 3 פעמים ביום
ד. בתוספת לטיפול האנטי ויראלי מומלץ להוסיף Prednisone במינון 60 מ"ג פעם

94. בן 68 , מורה בגמלאות, ללא מחלות רקע משמעותיות, מובא לבדיקה פסיכיאטרית על ידי בנו עקב שינוי בהתנהגות. הבן מתאר שאביו אוכל ממתקים בכמות רבה, לעיתים נוסע באמצע הלילה למאפיות בערים אחרות כדי לקנות עוגות, ואף גנב מספר פעמים ממתקים מהסופרמרקט.
בשיחה- המטופל מתמצא בסיטואציה, שולל כל בעיה התנהגותית או קוגניטיבית.
במבחן MMSE השיג תוצאה של 28/30 .
מה יהיו ממצאי המבחנים הנוספים?

א. מבחן MOCA יראה פגיעה בחשיבה מופשטת
ב. מבחנים נוירוקוגניטיביים יראו פגיעה בתפקודי VISUOSPACIAL
ג. מבחן GERIATRIC DEPRESSION SCALE יתאים לדיכאון
ד. מבחנים נוירוקוגניטיביים יראו ירידה בזיכרון מילולי

95. בת 66, אלמנה תשושה בתפקודה, מתגוררת בביתה, הופנתה למחלקה לרפואה דחופה עקב חום ושועל טורדני, במיון בהכרה מלאה, נמדד חום 38.5, סטורציה 97% באוויר חדר, לחץ דם 96/54 , דופק 100 לדקה, 25 נשימות לדקה, ללא שימוש בשרירי עזר. בהאזנה לריאות קרפיטציות בבסיס ריאה שמאלית.
צילום חזה מצורף **בתמונה מספר 11.**

בבדיקות מעבדה לויקוציטים 11000 עם סטייה שמאלה, המוגלובין תקין, קריאטינין 1.2, BUN 32. 14. מה ה- CURB65?

א. 2
ב. 3
ג. 4
ד. 5

96. קביעת איזה סטטוס חורגת מסמכות מקצועית של רופא מומחה בגריאטרית?

א. סיעודי
ב. שיקומי
ג. מונשם כרוני
ד. סיעודי מורכב

97. מה מהווה גורם סיכון בחולה פרקינסון לפתח דמנציה?

א. הופעת סימנים מוטורים חד צדדיים
ב. אבחנת מחלה בגיל צעיר
ג. חומרת הרעד
ד. ברדיקינזיה

98. מי מהחולים הבאים מתאים לאשפוז במחלקה לסיעוד מורכב?

א. בן 88, מרותק למיטה, ניזון דרך גסטרוסטום, נושא קתטר בדרכי השתן
ב. בן 93, היה עצמאי בביתו, כעת מרותק למיטה לאחר ניתוח LAPAROTOMY
ג. בן 72, מונשם דרך טרכיאוסטום
ד. בן 78, פאראפלג, סובל מפצע לחץ UNSTAGABLE בסאקרום

99. מהי תופעת לוואי אפשרית של Denosumab (פרוליה) ?

א. אוסטאונקרוזיס של הלסת
ב. אי ספיקה כלייתית חדה
ג. החמרה באי ספיקת לב
ד. טרומבוציטוזיס

100. בן 88 שוחרר ממחלקת עור לאחר אשפוז עם אבחנה של Bullous pemphigoid. אילו אברים נוספים פרט לעור יכולים להיפגע מהמחלה?

א. פגיעה במערכת ההולכה של הלב עם סיכון ל- AV BLOCK
ב. פגיעה ברירות של הפה והעיניים
ג. פגיעה בעצמות דמויית מחלת פאג'ט
ד. פגיעה כלייתית טובולרית הגורמת להיפוקלמיה והיפומגנזמיה

101. בת 80, תשושה בתפקודה, גרה לבד בביתה. ברקע: סוכרת ויתר לחץ דם. מטופלת ב- METFORMIN, AMLODIPIN ו- ASPIRIN . התקבלה לאשפוז במחלקת פנימית גריאטרית בעקבות אירועי שלשול מרובים מזה מספר ימים. בבדיקתה: סימני התייבשות, ל"ד 100/60.

בבדיקת דם:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	142	135-146
K mmol/L	4.5	3.5-5.3
Cl mmol/L	115	95-110
Albumin g/L	45	35-50
HCO3 mmol/L	19	21-26
PCO2 mmHg	34	35-46
PH	7.30	7.35-7.45

מה מהבאים מתאר **נכון** את מאזן החומצה בסיס?

א. למטופלת חמצת מטבולית High Anion Gap בשל הרעלת MEFORMIN
ב. למטופלת חמצת מטבולית Non Anion Gap בשל שלשול
ג. למטופלת חמצת מטבולית Non Anion Gap בשל קטואצידוזיס
ד. למטופלת חמצת מטבולית Hight Anion Gap בשל RTA4 על רקע מחלת סוכרת

102. בן 72 אושפז לברור חום ממושך. סובל מחום עד 38 יותר בשעות הערב מזה כחודש. בברור ראשוני – ספירת דם, כימיה, צילום חזה ותרביות דם ושתן היו שליליות. לאחר ברור נרחב נמצא כסובל ממאירות

איזו ממאירות (לא מטסטטית) מהבאות עושה תמונה של FUO בסבירות הגבוהה ביותר?

א. Hepatocellular carcinoma
ב. Esophageal carcinoma
ג. Prostate carcinoma
ד. Mucoepidermoic carcinoma of the parotid

103. בת 86, הובאה למיון בשל עצירות מזה כשבועיים, בחילה וישנוניות מזה כשלושה ימים. בבדיקתה: ישנונית, אך ניתן להעירה. סימנים חיוניים תקינים. צילום חזה תקין.
במעבדה Ca=12.3.
מה ניתן להסיק מבדיקות נוספות בברור היפרקלצמיה?
(לציין שהנורמה לרמת PTH היא 15-65 פיקוגרם/מ"ל)

א. בתיקון לאלבומין 50 גרם/ד"ל (הערך העליון של הנורמה) לא מדובר בהיפרקלצמיה אמיתית
ב. רמת PTH=60pg/ml שוללת היפרפאראתירואידיזם
ג. אם מדובר בהיפרפאראתירואידיזם תהיה עליה גם בערכי סידן וגם בערכי פוספט
ד. אם רמת PTH=4pg/ml יש חשד גבוה לממאירות

104. בן 64, ברקע יתר לחץ דם. התקבל למחלקה לרפואה דחופה עקב כאבים בחזה וחולשה.
סימנים חיוניים- דופק 52 סדיר, לחץ דם 104/55, סטורציה 96, נשימות 18 לדקה.
בבדיקה גופנית - כניסת אויר טובה לריאות, גודש ורידי צוארי מקסימלי.
בבדיקת אק"ג: **תמונה מספר 12**
מה סביר שיימצא בהמשך הברור של אותו מטופל?

א. בבדיקות הדם- היפוקלצמיה
ב. ב- CTA – תסחיף ריאתי
ג. באק"ג ימני- אוטם של חדר ימין
ד. בצינתור- CORONARY SPASM

105. בן 87, כחלק מבירור אירוע של עילפון (syncope) נבדק ל"ד בעת שינוי תנוחה:
ל"ד בשכיבה 150/90 דופק 70 לדקה סדיר, ל"ד בעמידה כעבור 3 דקות 100/80 דופק 90 סדיר.
איזו אבחנה נוספת יכולה להיות למטופל זה?

א. Amyloidosis
ב. טיפול תרופתי ב- prednisone
ג. מצב לאחר כריתת טחול בילדות
ד. הרעלת ויטמין D

106. בת 82, מתגוררת בביתה. ברקע: מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, תת פעילות של בלוטת התריס, אוסטיאופורוזיס ומצב לאחר שחזור וקיבוע מפרק הירך מימין לפני כשנתיים על רקע שבר אינטרטרוכנטרי.

אושפזה עקב כאב ואודם מקומי באזור הניתוח. בבדיקה נצפה סינוס מפריש מעל הצלקת הניתוחית. לאחר השלמת בירור מעבדתי ודימות CT עולה חשד לזיהום המשתל (Periprosthetic Joint Infection). בתרבית מההפרשה נמצא Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). לאורך אשפוזה עד כה המטופלת יציבה המודינמית ונשימתית, ללא חום וללא סימני ספסיס.

מה מהבאים נכון בהתייחס לאבחנה במקרה זה?

א. שקיעת הדם המוחשת שנמדדה במהלך אשפוזה הינה ספציפית אך לא רגישה

ב. בדיקת מיפוי עצם (Bone scan) הינה בדיקה רגישה יותר מבדיקת ה- CT לאבחנת הזיהום במשתל במטופלת זו

ג. סף האבחנה (Threshold values) של זיהום משתל מפרקי בכל המפרקים הוא מעל 1700 תאים/ מ"ל

ד. Staphylococcus Aureus הוא המזהם השכיח בזיהומי משתלים מאוחרים

107. בן 94, מתגורר בביתו עם מטפל צמוד, סיעודי בתפקוד עם דמנציה קלה.
ברקע: סוכרת, יתר לחץ דם, אי ספיקת כליות כרונית (קריאטינין בסיסי 1.5 מ"ג/ד"ל), אירוע מוחי בעבר.
תרופות קבועות: ASPIRIN, METFORMIN, INSULIN, RAMIPRIL, DONEPEZIL.

מגיע למיון מבולבל ובאי שקט ניכר.
באנמנזה מהמטפל עולה כי לפני שבועיים חלה בדלקת ריאות משנית ל- COVID-19, אשר טופלה במסגרת אשפוז בית כולל טיפול ב- DEXAMETASONE ו- ENOXAPARIN.
תחת הטיפול חל שיפור נשימתי. הוא סיים את הטיפול והוכר כמבריא, אך המשיך להתלונן על חולשה, וחלה החמרה בהדרגתית במצבו, כולל מיעוט באוכל ושתייה, החמרה קוגניטיבית עם אירועי בלבול ואי שקט תכופים. בהערכה ראשונית במיון המטופל באי שקט וחלש
סימנים חיוניים: דופק 115, ל"ד 100/60, סטורציה 94, ללא מצוקה נשימתית.
בבדיקת סוכר בגלוקומטר ערכים גבוהים מיכולת המדידה (HIGH). סטיק שתן ללא קטונים.
במעבדה ראשונית-

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	145	135-146
K mmol/L	5	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	2.7	0.7-1.3
UREA mg/dL	98	17-43
Ca mg/dL	10	8.5-10.5
Albumin g/L	30	35-50
WBC 10e3/µL	9.8	4.0-11.0
HgB g/dL	14	13.5-17.5
Plt 10e3/µL	350	150-450

בדיקת גזים- ערכים בטווח הנורמה.
אוסמולליות הדם 350 mOsm/kG (הנורמה 275-295 mOsm/kg)
מה הטיפול הראשוני בבעיה זו ?

א. מאחר וערכי הנתרן תקינים עיקר הטיפול הראשוני יכלול הפסקת טיפול ליתר לחץ דם והתחלת טיפול באינסולין
ב. בחשד למחלת אדיסון כל טיפול צריך לכלול גם מתן IV HYDROCORTISONE
ג. טיפול הראשוני יהיה הכנסת זונדה ומתן מהיר של 3 ליטר מים בשילוב הרצת שני ליטר סלין 0.45% עם אינסולין
ד. הטיפול הראשוני יתמקד בהחזר נוזלים ראשוני מהיר בסליין 0.9% ובולוס אינסולין

108. מה הגישה הטיפולית בהיפרתירואידיזם משני לטיפול ב- AMIODARONE (amiodarone-induced thyrotoxicosis)?

א. הטיפול בסטרואידים מביא לשיפור ברוב החולים תוך חודש
ב. טיפול בתרופות אנטי-תירואיד יעיל מאוד אך בעל סיכון לנויטרופניה
ג. הפסקת הטיפול ב- AMIODARONE משפרת את הפגיעה בתירואיד תוך מספר שבועות
ד. ניתוח של Near-total thyroidectomy הוא בעל יעילות לטווח ארוך

109 . בן 80, מאושפז במחלקה פנימית גריאטרית עקב זיהום בדרכי בשתן. המטופל נשא קתטר שתן קבוע מזה שנתיים.
ביום השני של האשפוז עבר בדיקת CT בטן עם חומר ניגוד ונשלל אבצס.
ביום השלישי לאשפוזו הוחל טיפול אנטיביוטי ב- Amikacin לפי רגישות החיידק.
במהלך האשפוז החום ירד, ללא דהידרציה, לחץ דם יציב ותפוקת שתן תקינה.
ביום העשירי לאשפוז קריאטינין עלה מ-1 עד 3.
מה מהבאים יתמוך באבחנה של אי ספיקת כליות משנית לטיפול באמינוגלוקוזידים ?

א. יחס BUN/CREATININE מעל 20
ב. אוליגוריה
ג. GRANULAR CASTS בבדיקת שתן למיקרוסקופ
ד. היפרמגנזמיה

110. מטופל בן 75, יליד אתיופיה, שמור קוגניטיבית, עצמאי בתפקוד.
ברקע: אי ספיקת לב, ממאירות פרוסטטה, לא ידוע על פיזור משני.
מתאשפז בשל קוצר נשימה. בצילום חזה: תפליט פלאורלי בינוני דו צדדי.
במחלקה בוצע ניקור של התפליט עם הוצאת חצי ליטר נוזל צלול, מצורפת טבלה עם תשובות מעבדה ראשוניות:

בדיקה	דם	תפליט
LDH U/L	240	120
Protein g/dL	6.5	3

מה ניתן להסיק מבדיקות המעבדה מהתפליט?

א. נוכח תפליט אקסודטיבי והסיפור הקליני מומלץ מלבד הבדיקות השגרתיות לשלוח את הנוזל לציטולוגיה ול-ADA (Adenosine Deaminase)
ב. מדובר בתפליט טרנסודטיבי. נוכח הסיפור הקליני יש לטייב טיפול באי ספיקת לב ולהשלים בירור ליציאה מאיזון אי ספיקת לב
ג. על אף שסביר שהתפליט אקסודטיבי יש כ- 25% סיכוי שלמעשה מדובר בטעות והתפליט למעשה טרנסודטיבי
ד. אין די נתונים על מנת להעריך את סוג התפליט

111. בת 76, שמורה קוגניטיבית ועצמאית בביתה, הופנתה למחלקה לרפואה דחופה בשל החמרה בקוצר נשימה ושיעול בשבוע האחרון. ברקע ידוע על COPD, ללא טיפול תרופתי קבוע. בקבלתה נושמת 22-24 נשימות לדקה, סטורציה 88% באוויר חדר, מתוקנת ל93% עם משקפי חמצן, לחץ דם, דופק וחום סיסטמי תקינים. בהאזנה לריאות אקספיריום מאורך עם צפצופים סוף אקספירטוריים. בבדיקות דם WBC 12.6, CRP 65 mgr\L. בצילום חזה ללא עדות ברורה לתסנין או גודש.

מה השיקול הטיפולי **הנכון** במקרה זה?

א. סטורציה של 88% באוויר חדר הינה מספקת בחולי COPD בשל סיכון לצבירת CO_2, ניתן לטפל באינהלציות בלבד
ב. אם אין צבירת CO_2 אין אינדיקציה להתחלת טיפול סיסטמי בסטרואידים
ג. לאור מדדים גבוליים של המטופלת בקבלתה, מומלץ לבצע כעת תפקודי ריאות
ד. למרות היעדר חום סיסטמי וצילום חזה תקין, סביר להתחיל טיפול אנטיביוטי אמפירי

112. בן 77, שמור קוגניטיבית ותשוש תפקודית, נמצא במהלך בירור של שלשול לסירוגין, לדבריו מזה כשנה. מציין כאבי בטן דיפוזיים, בעיקר לאחר ארוחות. ירד כ-7% ממשקלו בשנה האחרונה. שולל דם או ריר ביציאות. בדיקות דם בגדר הנורמה, המוגלובין 15.4. ברקע: סוכרת, עישון, יתר לחץ דם, דיסליפידמיה.
כחלק מהבירור בוצע CTA בטן, הודגמו הצירויות משמעותיות ב-SMA ו-IMA (Inferior\Superior Mesenteric Artery), ללא ממצאים פתולוגיים נוספים.
מהי הגישה הטיפולית המתאימה?

א. לאור חשד לאיסכמיה מזנטריאלית, יש להתחיל בהקדם טיפול באנטיקואגולציה
ב. יש להתחיל טיפול פומי בניטרטים, אשר משפרים סימפטומים של Abdominal Angina ולהפנותו לגסטרואנטרולוג להמשך בירור
ג. יש להפנות את המטופל לכירורג כלי דם לשקול טיפול באנגיופלסטיה והשתלת תומכן
ד. ההיצרויות -בSMA ו -IMA לבדן אינן מסבירות את תלונותיו של המטופל. יש להמשיך בברור על ידי קולונוסקופיה

113. מה יכול להבדיל בין אנמיה של חוסר ברזל לבין אנמיה של מחלת דלקת כרונית?

א. מורפולוגיה של RBC
ב. ברזל בסרום
ג. Ferritin
ד. red cell distribution width – RDW

114. בן 70, מטופל ב- 5 FU בשל סרטן הושט.

פונה למיון בשל כאבים בבטן ימנית תחתונה ושלשולים. בבדיקתו חום 38.7 , בטן תפוחה, נוקשה, רגישה למישוש ותנגודת.

במעבדה: WBC – 2500, HB – 9.2, PLT – 170,000.

ב- CT התעבות ניכרת של דופן המעי של הצקום, עם בועות אוויר בדופן המעי, עכירות שומן מזנטריאלי ומיימת.

מהי האבחנה הסבירה ביותר של המטופל?

א. APPENDICITIS
ב. DIVERTICULITIS
ג. TYPHLITIS
ד. CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION

115. בת 79, הידועה כסובלת מ- RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) מזה כ-7 שנים מתלוננת על תפיחות גרמית במפרקי DIP's (Distal Interphalanges).

מה האבחנה האפשרית?

א. סביר להניח כי מדובר במחלת מפרקים ניוונית (OSTEOARTHRTITIS) ממנה המטופלת סובלת במקביל
ב. מדובר בחלק מהזדקנות נורמלית
ג. במטופלים סרופוזיטיבים (כלומר RHEUMATOID FACTOR חיובי) מעורבות DIP שכיחה כחלק מ-RA
ד. יש לבצע הערכה חוזרת של האבחנה של RA מכיוון שתפיחות גרמית במפרקי DIP לא אופיינית למחלה

116. בן 80, ברקע: אי ספיקת לב HFrEF וסוכרת. אושפז במחלקה פנימית גריאטרית בשל דליריום. רופא נקרא לבדוק את החולה בשל קוצר נשימה שהחל באופן חד. בבדיקתו: טכיפנאי, 30 נשימות לדקה, שימוש בשרירי עזר, סטורציה 75% באוויר חדר, ל"ד 150/70 דופק 80 .

בצילום חזה- **תמונה מספר 13**

מה הטיפול הראשוני שיש לתת לחולה בנוסף לתמיכת חמצן ?

א. מדובר בדלקת ריאות. להתחיל טיפול בנוזלים דרך הוריד, Ceftriaxone ו- Azithromycin

ב. צילום החזה אינו אבחנתי. יש להשלים CT חזה לפני החלטה על המשך טיפול

ג. מדובר בבצקת ריאות. יש להושיב את החולה, לתת טיפול ב- FUSID דרך הוריד, nitroglycerin תת לשוני, לשקול מורפין במינון נמוך

ד. לאור גורמי הסיכון כנראה ומדובר באירוע של PE. יש לתת מנה חד פעמית של ENOXAPARIN ולהשלים CTA באופן דחוף

117. בן 88, ברקע אי ספיקת לב עם EF-30%. פנה להתייעצות במרפאה בשל החמרה בחולשה כללית וקוצר נשימה. בבדיקתו סימני גודש ריאתי קל.

במעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
WBC 10e3/µL	5.8	4.0-11.0
HgB g/dL	9.3	13.2-17
MCV fL	75	80-96
FERRITIN ng/ml	30	14-163
TRANSFERRIN mg/dL	440	220-400
Plt 10e3/µL	387	150-450

תפקודי כליה וכבד, אלקטרוליטים, תפקודי תריס ורמות B12 וחומצה פולית בטווח התקין.

בהתייחס למחלות הרקע, תלונות המטופל, בדיקתו ובדיקות העזר, איזה מהבאים הוא הטיפול המומלץ ביותר לאנמיה?

א. תכשיר ברזל פומי

ב. אנלוג של אריתרופואטין במתן תת עורי

ג. מתן עירוי של packed cells

ד. תכשיר ברזל תוך ורידי

118. בת 79, עצמאית בתפקודה וללא חסר קוגניטיבי. הופנתה למחלקה לרפואה דחופה בשל ערכי לחץ דם גבוהים. ברקע: ידוע על ערכי לחץ דם סביב 145/85 mm/Hg תחת טיפול תרופתי. בקבלתה נמדד לחץ דם 210/115 mm/Hg . בבדיקה נצפה בבלבול, איטיות פסיכומוטורית וחוסר התמצאות בזמן ובמקום, ללא סימני צד. בבדיקת העיניים נמצאה פפילאדמה. במעבדה: קריאטנין 1.35 mg/dl (ערך קריאטנין אחרון היה 0.8 mg/dl) עם פרוטאינוריה.

מה הטיפול המתאים במצב זה?

א. הורדת ערך לחץ הדם לערכי הבסיס של המטופלת (סביב 145/85 mm/Hg) תוך דקות עד שעתיים באמצעות תכשירים ממשפחת חוסמי תעלות סידן (Calcium Channel Blocker)

ב. הורדת ערך לחץ הדם לטווח של 160/110 mm/Hg תוך דקות עד שעתיים באמצעות Nitroprusside תוך ורידי

ג. הורדת ערך לחץ הדם ב- 30% מערכו הנוכחי תוך 4 שעות באמצעות תכשירים ממשפחת מעכבי האנזים ACE כגון Captopril

ד. הורדת ערך לחץ הדם הסיסטולי לטווח של מתחת ל- 185 mm/Hg תוך 4 שעות באמצעות Hydralazine

119. מה השילוב הנכון בין סוג הזיהום העורי לבין חיידק הגורם לו בשכיחות גבוהה?

א. Folliculitis נגרם על ידי Staph aureus

ב. Necrotizing fasciitis נגרם על ידי Pseudomonas aeruginosa

ג. Hand-foot-and-mouth disease נגרם על ידי Parapoxvirus

ד. Erysipelas נגרם על ידי Mycobacterium marinum

120. בן 75 אושפז בבית חולים עקב שיעול ממושך ואובחן כחולה שחפת. הוחל טיפול תרופתי.

איזו התנהלות **נכונה** על מנת למנוע הדבקה לסביבה?

א. שהיה בתנאי בידוד אויר עד סיום הטיפול התרופתי

ב. טיפול תרופתי מונע לאנשי הצוות המטפל בעלי מנטו מעל 5 מ"מ

ג. טיפול תרופתי מונע לאשתו מושתלת הכליה אם מנטו מעל 5 מ"מ

ד. מעקב צילומי חזה לכל החשופים

121. מה **נכון** לגבי יעילות של טיפול תרופתי לסוכרת?

א. Semaglutide (אוזמפיק) מפחית אירועים קרדיו-ווסקולרים בחולים עם סוכרת סוג 2, אולם מעלה סיכון לרטינופתיה
ב. טיפול ב- empagliflozin (ג'ארדיאנס) מפחית את הסיכון לנפרופתיה אולם הראה עליה בסיכון לסרטן שלפוחית השתן
ג. Semaglutide (אוזמפיק) מעלה את הסיכון להידרדרות כלייתית בחולי סוכרת
ד. מעכבי DPP4 יותר אפקטיביים בשיפור האיזון הגליקמי לעומת הטיפול במטפורמין

122. מה כולל המנגנון של היפרפאראתירואידיזם משני לאי ספיקת כליות כרונית?

א. איבוד מוגבר של Phosphate בשתן משני לפגיעה טובולרית
ב. עליה ריאקטיבית של רמות calcitriol בדם
ג. עליה במסת הפראתירואיד
ד. שחרור סידן מדפנות כלי הדם

123. בן 66, סובל משחמת הכבד על רקע HEPATITIS C.
הגיע למחלקה לרפואה דחופה עקב הקאה דמית. בגסטרוסקופיה דחופה אובחנו דליות מדממות. טופל לייצוב המודינמי.
מה הטיפול התרופתי המתאים לדימום חריף מדליות בוושט?

א. IV dexametasone
ב. IV somatostatin
ג. IV propranolol
ד. IV pantoprazole (controloc)

124. במהלך ברור לשקיעת דם מוחשת נמצאו אצל חולה הממצאים הבאים: חלבון מונוקלונאלי בסרום, non-IgM type מתחת ל-30 ג/דל, תאי פלזמה מונוקלונאלים במח העצם מתחת ל- 10%, רמות קלציום והמוגלובין תקינות, תפקודי כליות תקינים וללא ממצאים פתולוגיים בעצמות.
מה מהבאים נכון לגבי המשך המעקב והטיפול?

א. במידה ויחס שרשראות קאפא ללמדה מופרע, יש לבצע מעקב אלקטרופורזה אחת לשנתיים
ב. במידה וקיימת פולינוירופתיה ניתן לשקול טיפול למחלת תאי הפלזמה
ג. לחולים ברמת סיכון גבוהה יש סיכוי של 20% להתקדם לmultiple myeloma לאחר 20 שנים.
ד. שכיחות המחלה בבני 75 ומעלה היא כ 1%

125. מה סוג הלימפומה השכיח ביותר בחולי RHEUMATOID ARHTRITIS?

א. Follicular lymphoma
ב. Malt lymphoma
ג. Mantle cell lymphoma
ד. Diffuse Large B Cell Lymphoma

126. מהו הסימן הרדיוגרפי בבדיקת אולטראסאונד האופייני לפרק שנפגע במחלת גאוט?

א. double contour sign
ב. sonographic eye sign
ג. bull eye sign
ד. camel hump sign

127. בת 83, פנתה למחלקה לרפואה דחופה עקב קוצר נשימה וכאבים בכתף ימין.
צילום חזה - **תמונה מספר 14**
מהם גורמי סיכון אפשריים לתופעה זו?

א. עודף משקל
ב. עישון
ג. מין נקבה
ד. IMMOBILITY

128. איזה מהמהלכים הבאים מתאר בצורה נכונה סדר פעולות טיפול ב- CARDIAC ARREST?

א. ב- PULSLESS VT : עיסוי חזה-> דפיברילציה-> המשך עיסוי חזה->מתן IV ADRENALINE -> מתן IV AMIODARONE
ב. באסיסטולה: עיסוי חזה-> דפיברילציה-> המשך עיסוי חזה-> מתן IV ADRENALINE -> המשך עיסוי חזה
ג. ב- VENTRICULAR FIBRILLATION: אינטובציה-> עיסוי חזה->דפיברילציה -> המשך עיסוי חזה-> מתן IV ADRENALINE
ד. בברדיקרדיה: מתן IV ATROPINE->עיסוי חזה-> אינטובציה ->המשך עיסוי חזה-> מתן IV ADRENALINE

129. במטופל עם אירוע כלילי חריף ללא עליות ST (NSTEMI/ACS), איזה מהבאים מהווה קריטריון להערכת סיכון לתמותה על פי TIMI Risk Score for UA/NSTEMI?

א. רקע של סוכרת ללא גורמי סיכון אחרים
ב. היצרות קורונרית ידועה של מעל 50%
ג. שימוש באספירין במשך חודש לפחות לפני האירוע
ד. צניחות ST של מעל 0.2 מ"מ בשלושה חיבורי אק"ג לפחות

130. בן 69, ברקע אי ספיקת לב משנית ל- Aortic stenosis. פנה לבית חולים בשל חום 38-38.5 מזה 5 ימים.

בדיקת TTE נמצאת ווגטציה על מסתם אאורטאלי. במעקב עד כה ללא צמיחות בתרביות דם.

איזה ממצא נוסף יהווה קריטריון לאבחנה של אנדוקרדיטיס על פי DUKE CRITERIA ?

א. צמיחה של Viridans streptococci בתרבית אחת

ב. ממצא באקו של היצרות חדשה של מסתם

ג. פרוטאינוריה מעל 1 גרם/24 שעות

ד. CRP>80

131. מה מתאר קשר נכון בין תרופה לסוכרת לתופעת לוואי שלה?

א. Metformin - עצירות

ב. Empagliflozin (ג'ארדיאנס) - פיילונפריטיס

ג. Repaglinide (נובונורם) – כאבי שרירים

ד. Liraglutide (ויקטוזה) – היפותירואידיזם

132. בן 65, אובחן לפני חודשיים כסובל מיתר לחץ דם. כעת מטופל ב- Ramipril Amlodipine, Atenolol במינונים מקסימליים. ערכי לחץ דם בבדיקה במרפאה 160/90. מתלונן על חולשה כללית וחוסר תיאבון.

בבדיקות הדם:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	2.9	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.1	0.7-1.3
BUN mg/dL	21	5-25

מה הצעד הבא בבירור?

א. אין צורך בבירור נוסף

ב. בדיקת cortisol בדם

ג. בדיקת Aldosterone-renin ratio

ד. בדיקת אולטרסאונד כליות ודרכי השתן

133. בן 81, ברקע: אי ספיקת כליות כרונית עם קריאטנין בסיס 2, ischemic cardiomyopathy עם EF של 35%. אושפז בפנימית בשל זיהום בדרכי השתן. יום לאחר אשפוזו המטופל בקוצר נשימה, סטורציה 92% באוויר חדר, לחץ דם- 143/85, דופק 86, שימוש בשרירי עזר. בבדיקה גופנית חרחורים מפושטים לחים, כניסת אוויר מופחתת בבסיסי הריאות. בצילום חזה- בצקת ריאות.
מה הגישה הטיפולית הנכונה?

א. עקב אי ספיקה כלייתית בכדי להגיע לטיפול אפקטיבי יש לטפל במטופל זה ב- FUSID במינון גבוה
ב. טיפול ב- MORPHINE מומלץ היות והראה שיפור פרוגנוסטי בחולים אלה
ג. יש לטפל במסכת חמצן במינימום הנדרש להשגת סטורציה מעל 90% למניעת צבירת CO2
ד. עקב אי ספיקה כלייתית יש להעדיף טיפול משתן ב- DISOTHIASIDE

134. איזו מהבאות היא <u>התוויה מוחלטת</u> להתחלת טיפול בהמודיאליזה בחולה עם CKD דרגה 5 ?

א. עדות לתפליט פריקרדיאלי בינוני באקו לב
ב. היפרפוספטמיה 12 מ"ג/ד"ל
ג. חמצת מטבולית High anion gap
ד. היפונתרמיה 110 מא"ק/ל

135. בן 80, מאושפז במחלקה פנימית. בעברו: כיב בתריסריון לפני כ- 30 שנים ועבר ניתוח Antrectomy with a Billroth II anastomosis.
אילו סיבוכים מאוחרים יכולים להיות לניתוח זה?

א. תת ספיגה של ויטמין C
ב. סיכון לחזרה של הכיב באזור האנסטומוזה הניתוחית
ג. סיכון מוגבר לעצירות
ד. ברדיקרדיה לאחר ארוחה גדולה

136. מה מתאר נכון השפעות של תרופות ל- Myelodysplastic syndrome (MDS) ?

א. Decitabine משפר ספירות דם אך לא הוכח שמשפר פרוגנוזה
ב. טיפול אימונוסופרסיבי ב- anti-CD52 monoclonal antibody alemtuzumab מוכח כיעיל יותר באוכלוסייה קשישה
ג. טיפול משולב ב-Decitabine ו-Lenalidomide יכול להביא להחלמה ב- 10% מהחולים
ד. Lenalidomide גורם לקרישיות יתר

137. מה מבין הבאים יגרום להארכת PT?

א. חסר פקטור VII
ב. חסר פקטור XIII
ג. טיפול ב- THROMBIN INHIBITORS
ד. DIC

138 . כל התופעות הבאות יכולות להיות משניות לקרינה לבית החזה **פרט ל-**

א. chronic constrictive pericarditis
ב. lung emphysema
ג. esophageal carcinoma
ד. myocardial infarction

139. מה המהימנות של בדיקת מיפוי ריאות לאבחנת תסחיף ריאתי חד?

א. תשובת מיפוי תקינה שוללת תסחיף ב-90% מהמקרים
ב. בתשובת מיפוי של סבירות גבוהה, הסיכון לתסחיף הוא מעל 90%
ג. לרוב ניתן לקבל תשובה ברורה מתוצאות המיפוי
ד. ברוב הנבדקים עם תסחיף תהיה סבירות גבוהה במיפוי

140. בן 80, הסובל מ- LARGE CELL LYMPHOMA החל טיפול כימותרפי בפרוטוקול R-CHOP. מה הממצאים המעבדתיים היכולים להחשיד ל- TUMOR LYSIS SYNDROME?

א. היפרקלצמיה
ב. היפופוספטמיה
ג. היפרנתרמיה
ד. היפרקלמיה

141. בן 65, ברקע: אי ספיקת לב סיסטולית HFrEF עם EF=30%.
מה המשפט **הנכון** לגבי התערבויות להפחתת סיכון לתמותה בחולה זה?

א. Calcium channel blockers מפחיתים תמותה רק בחולים עם HFpEF
ב. אלדוסטרון אנטגוניסט (Spironolactone) הפחית אשפוזים אך לא תמותה בחולים עם HFrEF
ג. השתלת CRTD הפחיתה תמותה בחולים עם QRS>ms130 ו-RBBB באק"ג
ד. טיפול ב - sacubitril-valsartan (אנטרסטו) הראה שיפור בשרידות בהשוואה לטיפול ב- ACEI בלבד

142. בן 75, הסובל ברקע מדיכאון ומטופל ב- MIRTAZAPINE , ללא מחלות רקע אחרות מאושפז במחלקה פנימית גריאטרית לצורך בירור אירועים של סינקופה. ברקע: יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, דיסליפידמיה וסוכרת. המטופל מתלונן על חולשה כללית.
בדיקת אק"ג- **תמונה מספר 15**
מהי האבחנה ומהו הטיפול המתאים במצב המתואר?

א. הממצא יכול להיות משני להיפוקלמיה ואז יש צורך במתן אשלגן
ב. מדובר ב- third degree AV block ולכן יש אינדיקציה להשתיל קוצב לב
ג. מדובר ב- Mobitz type 2 ולכן הטיפול הוא אטרופין דרך הוריד
ד. הממצא יכול להיות משני לטיפול ב- MIRTAZAPINE ויחלוף עם הפסק הטיפול

143. כל החיידקים הבאים מהווים סיכון מוגבר לספסיס בחולה לאחר כריתת טחול **פרט ל-**

א. Streptococcus pneumonia
ב. Staph Aureus
ג. Haemophilus influenza
ד. Neisseria meningitidis

144. בן 65, ללא מחלות רקע משמעותיות מובא למחלקה לרפואה דחופה עקב חום ובלבול.
מבוצעת בדיקת ניקור מותני בחשד לאנצפליטיס.
מה הממצא האופייני לאנצפליטיס בניקור מותני?

א. גלוקוז <50
ב. לויקוציטים >500
ג. רוב התאים הלבנים הם לימפוציטים
ד. עליה של חלבון לפחות פי 3 מהנורמה

145. בן 64, סובל מסוכרת ידועה מזה עשור, מחלת לב איסכמית עם צנתור והשתלת סטנט ל-LAD לפני שנתיים, אי ספיקת כליות עם קריאטנין בסיס 1.2.

ללא תלונות, מגיע לבדיקה שגרתית.

תרופות: Januet (Sitagliptin/ Metformin), Aspirin, Ramipril, Atorvastatin 80 mg, Omeprazole

במעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.2	0.7-1.3
BUN mg/dL	24	5-25
HbA1C	7.3	
LDL mg/dL	112	<100
HDL mg/dL	34	>60
Triglycerides mg/dL	357	<150
Alb/Crea ratio	520	<30

מה **נכון** בנוגע להמשך הטיפול בסוכרת ובהיפרליפידמיה אצל מטופל זה?

א. שימוש בסטטינים עלול להחמיר את הסוכרת ולפיכך כדאי להימנע ממנו

ב. לאור האלבומינוריה והפגיעה הכלייתית מומלץ להוסיף טיפול ממשפחת ה- DPP4

ג. בנוסף לטיפול בסטטינים, המטופל זקוק גם לטיפול ב- Bezafibrate

ד. מומלץ להוסיף טיפול ב –Ezetimibe (אזטרול)

146. בן 74 פנה לברור עקב כאב בטן, שלשול ודמם רקטלי.

מה **נכון** לגבי המשך הברור?

א. במידה ואבחנה היא irritable bowel נמצא עליה לא ספציפית של calprotectin בצואה

ב. ממצא של טרומבוציטוזיס יכול לכוון למחלת מעי דלקתית כמו Ulcerative Colitis

ג. שלשול לילי מרמז לאבחנה של Clostridium difficile Infection

ד. רמת calprotectin יכולה להבדיל בין Ulcerative Colitis ל- Crohn's Disease

147. איזה מהבאים מתאר קשר נכון בין הממאירות ההמטולוגית למוטציה הגנטית האופיינית?

א. CHRONIC MYELOID LEUKEMIA- טרנסלוקציה 9;21
ב. PAROXYSMAL NUTRURIAL HEMOGLOBINURIA – מוטציה בכרומוזום 8
ג. T CELL LYMPHOMA- מוטציה ב- HLA-CD20
ד. ESSENTIAL THROMBOCYTOSIS– מוטציה ב- JAK2

148. בן 75, הגיע לרופא עיניים עקב טשטוש ראיה. הוא מדווח על קושי בפתיחת עין ימין ויובש בעין. רופא העיניים בדק את החולה, ראה את הממצא בתמונה ושלח אותו לבית חולים להערכה.

תמונה מספר 16

מה החשד לפי הממצא בעיניים?

א. מחלת GRAVES עם THYROID STORM
ב. תסמונת HORNER משנית לגידול ריאתי
ג. מינון יתר של אופיואידים
ד. מייסטניה גרביס פאראנאופלסטית

149. בן 76, שמור קוגניטיבית ועצמאי, מהבוקר מתלונן על חולשה והרגשת דפיקות לב מהירות, סימנים חיוניים תקינים.

אק"ג **- תמונה מספר 17**

איזה משפט מאפיין את האפידמיולוגיה של מחלתו?

א. השכיחות באנשים מעל גיל 80 הוא סביב 10%
ב. ברוב החולים ניתן לזהות trigger כמו היפתירואדיזם או תסחיף ריאתי
ג. שכיח יותר אצל נשים מאשר אצל גברים
ד. שכיח יותר אצל אנשים רזים

150. מי מהמטופלים הבאים עומד בקריטריון לאבחנה של סוכרת?

א. מטופל שמתלונן על קוצר נשימה במאמץ, ערך סוכר במרפאה של 219
ב. מטופל שמתלונן על כאבים בפרקים, המוגלובין מסוכרר (A1C) של 6.2
ג. מטופל שמתלונן על צמא ופוליאוריה, ערך סוכר במרפאה 217
ד. מטופל אסימפטומטי עם תוצאה של סוכר 173 שעתיים לאחר העמסת סוכר של 75 גרם

בהצלחה